核心精讲

大肠癌

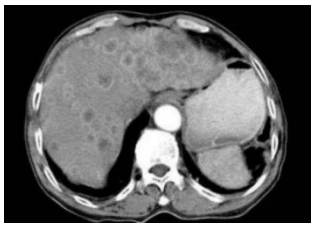
性感认识：把握不同手术指征

一、临床表现和检查

外科　阑尾炎2&大肠癌
00:37:59--00:48:04

1.中老年排便习惯和粪便性状改变（最早、最常见的症状），便血（最主要的报警症状）

2.病理



①腺癌多见

②淋巴转移最早最常见

③晚期血道转移最常至肝→牛眼征（边缘明显环形强化）

④伴肝、肺、腹股沟淋巴转移：可能同时手术（预后好）

「理顺知识点」

- 大肠癌晚期经门静脉转移至肝
- 牛眼征说明了肿瘤的异质性（单克隆来源的肿瘤细胞发生亚克隆）：外层肿瘤细胞血供丰富，内侧肿瘤细胞血供差
- 大肠癌的预后较好，当远处转移的范围较小时，可能同时手术
- 大肠癌转移至肝，出现弥漫性病变（长满了）→无法手术
- 仅有一个转移灶或出现三个转移灶但局限在一个肝段、肝叶→可手术

3.检查

①首选：直肠指检（70%低位直肠癌触及不规则、质硬、易出血肿物）

②金标准：结肠镜

③CEA（癌胚抗原）：判断预后、监测复发、辅助诊断。CEA与肿瘤分期有关；术后CEA未明显下降可提示肿瘤残留；术后CEA持续升高可提示肿瘤复发

④大便隐血试验：筛查（可持续阳性）Vs. 胃癌：大便隐血试验筛查

⑤CT/MRI、腔内超声、超声内镜：明确局部浸润、转移等以分期

4.术前肠道准备：预防性用抗生素，术前2-3天进流食，术前1天和手术当天清晨灌肠（聚乙二醇/甘露醇）0123

二、结肠癌（乙状结肠多见）

外科　阑尾炎2&大肠癌
00:48:04--01:02:36

1.大体类型（左亲右拢）

①溃疡型

②隆起型：多为右侧，多有腹部肿块和全身症状（低热、贫血、消瘦）

③浸润型：多为左侧，多有梗阻（大便细）、便血

「理顺知识点」

- 右侧结肠有吸收有关，因此更容易出现全身症状（消耗性改变）
- 左侧结肠更细（越靠近肛越细），因此容易出现梗阻
- 左侧结肠靠近肛门，因此容易便血

2.根据病灶的部位（肿瘤远端距切缘≥10cm 师姐）

①右半结肠切除术（盲肠、升结肠、结肠肝曲癌）

②横结肠切除术（横结肠中部癌）

③左半结肠切除术（结肠脾曲、降结肠癌）

④乙状结肠切除术（乙状结肠癌）



图 41-12　隆起型结肠癌



图 41-13　浸润型结肠癌



图 41-14　溃疡型结肠癌

「串联」

- 食管癌：切肿块及其上下缘≥5-8cm的组织「五八同城买食材」
- 胃癌：位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3-4cm「无端生事」
- 保乳乳腺癌切除术（切肿块+1-2cm组织）

「理顺知识点」

- 无单纯升、降结肠切除术

3.结肠癌并发急性肠梗阻

①右半：右半结肠切除、一期回肠-结肠吻合术

②左半：切除、一期吻合术，或支架置入、限期切除。若肠管扩张、水肿明显→切除肿瘤、近端造口与远端封闭

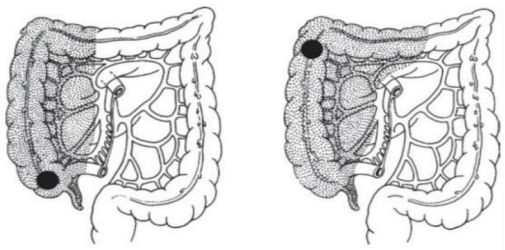


图 41-15　右半结肠切除范围

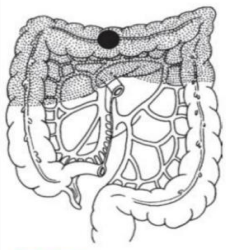


图 41-16　横结肠切除范围

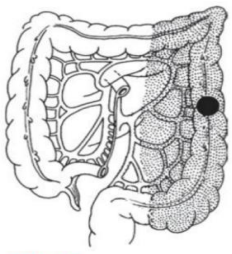


图 41-17　左半结肠切除范围

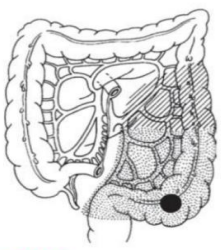


图 41-18　乙状结肠切除范围

三、直肠癌（最常见）

外科　阑尾炎2&大肠癌
01:02:36--01:24:56

1.多有梗阻（大便细）、便血、里急后重、肛门下坠感

2.肛门外括约肌和肛提肌

①受累：腹会阴切除Miles术（不保肛）mei肛门

②未受累：即使低位也可结肠-直肠低位吻合（Dixon术，切缘≥1cm）、或结肠-肛管超低位吻合（Parks/括约肌间切除ISR术）。行临时性回肠造口以减少吻合口漏（远近都可以打滴滴）

「理顺知识点」

- 保留肛门功能对患者术后生活质量至关重要，因此是否保肛是直肠癌手术的关键

3.根据病灶下缘距肛缘/齿状线的距离

①腹膜返折以下/距肛缘＜7/距齿状线＜5cm：Miles术

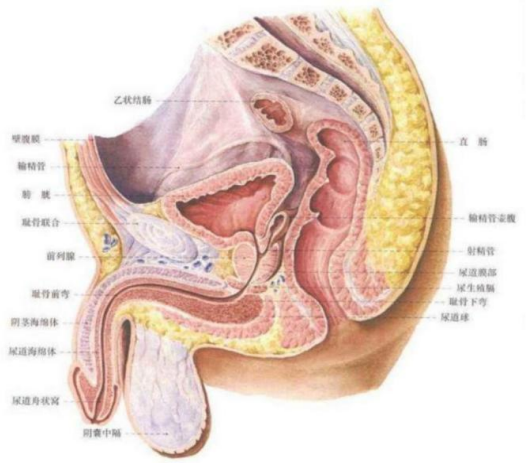
②腹膜返折以上/距肛缘≥7/距齿状线≥5cm：Dixon术（切缘≥2cm）儿子二奶

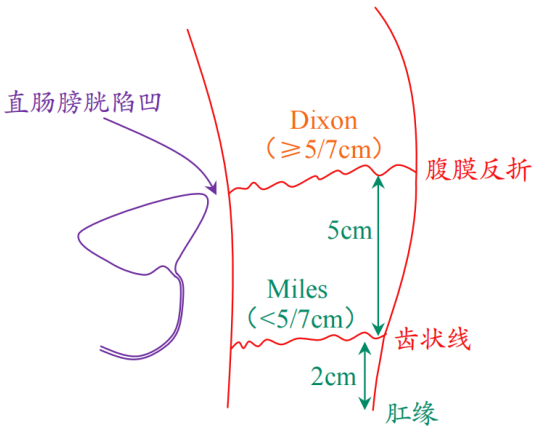
注意：直肠、乙状结肠交界处按直肠癌处理

4.Hartmann术（经腹直肠癌切除+近端造口/人工肛门+远端封闭肛门）

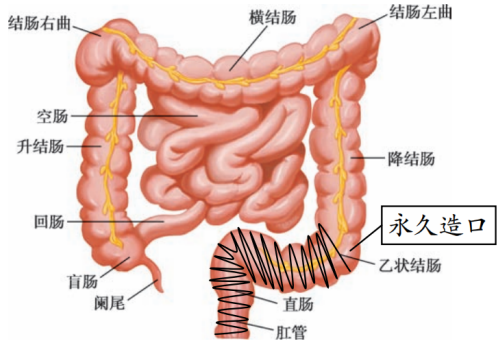
①急性肠梗阻不宜行Dixon术（本该做Dixon但急性肠梗阻一期吻合不上）

②不耐受Miles术（本该做Miles但现在不耐受不敢再切肛门）

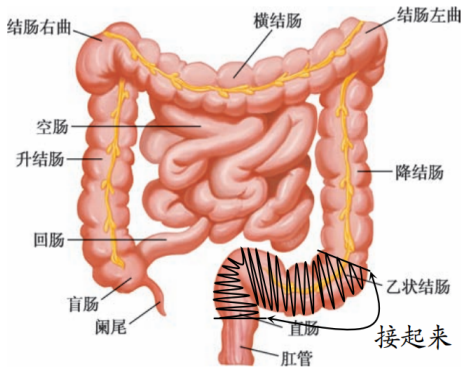




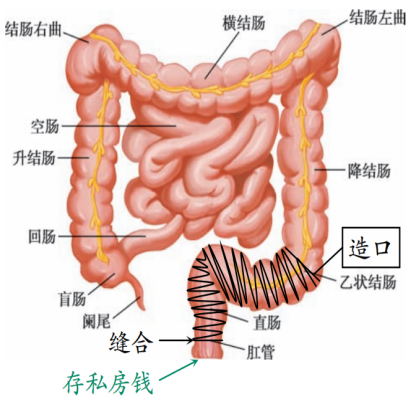
腹部切口进去切肿瘤、会阴切口进去切肛门



Miles 术
（经腹会阴根治术）



Dixon 术
（经腹根治术）



Miles　不能耐受

Dixon　急性肠梗阻

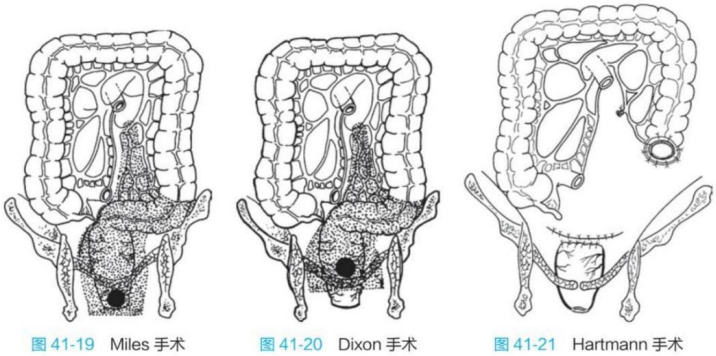


图 41-19　Miles 手术　　图 41-20　Dixon 手术　　图 41-21　Hartmann 手术

真题解析·大肠癌

外科　阑尾炎2&大肠癌
01:24:56--01:34:10

1.2013N83A对中国人直肠癌，直肠指诊的发现率是

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

2.2014N79A男性，73岁。因肠梗阻4天手术探查，术中发现直肠、乙状结肠交界部直径约3cm肿瘤，尚可活动，近端结肠扩张、水肿。宜采取的手术是　　直肠癌

A.横结肠造口术

B.Miles手术

C.Dixon手术

D.Hartmann手术

3.2014N86A目前认为Dixon手术的远端切缘至肿瘤最短的距离应是

A.2cm

B.3cm

C.4cm

D.5cm

乳腺癌保乳切除术：切肿块及其周围1～2cm
胃癌：5cm
食管癌：5～8cm
结肠癌：10cm

4.2015N86A男性，64岁。排便习惯改变、便血2个月，应首选的检查是

A.直肠指诊

B.直肠镜

C.钡灌肠

D.纤维结肠镜

5.2017N58A以下关于结肠癌患者血清CEA检测的临床意义的描述中，错误的是

A.术前CEA指标正常是缩小切除范围的依据

B.术后CEA未明显下降说明可能有肿瘤的残留

C.术后CEA持续升高提示肿瘤复发

D.CEA的阳性率和结肠癌的分期有关

　答案：1-5 D D A A A

6.2017N62A以下关于结肠癌的叙述中，正确的是

A.胃肠道肿瘤中预后最好

B.左侧结肠癌多表现为贫血

C.右侧结肠癌多表现为肠梗阻

D.早期以血道转移为主

7.2017N64A男性，62岁，脓血便3个月，结肠镜检距肛门处7cm可见直肠肿瘤，直径约2cm，活检示直肠癌，对该患者恰当的手术方案为

A.Hartmann术

B.Miles术

C.Dixon术

D.York-Mason术

8.2018N134-135B

A.Park术

B.Miles术

C.Hartmann术

D.Dixon术

男性，82岁，粪便带血及粘液1月。1周前结肠镜发现距肛缘15cm处环周肿物，镜身不能进入，取活检。病理报告：中分化腺癌。3天前腹胀、腹痛，停止排便排气，诊断肠梗阻。对该患者应选择的手术方式为

男性，58岁，脓血便2周，直肠指诊距肛缘4cm触及肿物，质硬，不活动，占据左侧大半周，指套有血渍，拟诊直肠癌，对该患者应选择的手术方式为

9.2020N100-102A男性，62岁，因大便有脓血1个月入院。肛门指诊在距肛缘7cm处触及直径4cm大小肿物，中间有溃疡，活检病理：中分化腺癌。全身检查无阳性发现，肝肺未见转移。

100.应采取的手术方式是

A.乙状结肠造口术

B.Miles术

C.Dixon术

D.Hartmann术

　答案：6-9 A C CB CAB

101.术后化疗5个疗程。2年后复查CT，发现左肝2个直径2–3cm结节，边缘清晰，强化明显，呈“牛眼征”。最可能的诊断是

A.直肠癌肝转移

B.原发性肝癌

C.肝多发血管瘤

D.多发肝囊肿

102.此时最合理的治疗方法是

A.继续化疗

B.左半肝切除术

C.观察

D.介入治疗

10.2021N62A男性，55岁。因腹痛一个月来诊，肠镜发现乙状结肠肿物，病理提示中分化腺癌。腹部CT提示乙状结肠肿物，大小5cm × 4cm，侵及浆膜，肝左外叶可见直径2cm转移灶，腹腔内未见肿大淋巴结。首选的治疗措施是

A.结肠癌根治术

B.结肠癌根治术联合肝左外叶切除术

C.全身化疗

D.局部放疗

　答案：10 B